

Bộ phận giả dương vật bơm hơi (IPP)

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Những điều cần biết trước khi phẫu thuật đặt bộ phận giả dương vật

Bộ phận giả dương vật bơm hơi (IPP) là thiết bị đặt hoàn toàn dưới da, giúp bạn có thể cương dương khi muốn — dành cho nam giới bị rối loạn cương dương không cải thiện với thuốc, tiêm, hoặc các phương pháp khác. Bạn điều khiển thiết bị qua bơm được giấu trong bìu. Tờ hướng dẫn này giải thích cách hoạt động, cách chuẩn bị và những gì cần chờ đợi.

Về ca phẫu thuật này

Khi **rối loạn cương dương (ED)** không cải thiện với thuốc, thiết bị hút chân không, hoặc tiêm, thì đặt bộ phận giả là bước tiếp theo đáng tin cậy nhất, với mức độ hài lòng rất cao. Một thiết bị gồm ba phần được đặt, tất cả đều giấu dưới da:

- Hai **ống trụ** mềm bên trong dương vật, bơm đầy dịch để làm cứng
- Một **bơm** trong bìu để bóp bơm căng và nhấn để xả
- Một **bình chứa** dịch đặt ở vùng bụng dưới

Cách sử dụng: bóp bơm nhiều lần để bơm căng ống trụ tạo sự cương; nhấn van xả để trở lại mềm. Bạn quyết định khi nào và trong bao lâu.

Điều cần biết

Đây là **lựa chọn lâu dài**. Việc đặt bộ phận giả làm thay đổi mô cương dương, do đó sau đó sự cương tự nhiên và các phương pháp điều trị ED khác (thuốc, tiêm) sẽ không còn hiệu quả — bộ phận giả trở thành cách duy nhất để bạn cương. Quan trọng là, nó **không thay đổi việc tiểu tiện, cảm giác, cực khoái, hoặc xuất tinh**. Như mọi thiết bị cấy ghép, có một số nguy cơ — chủ yếu là nhiễm trùng, và thiết bị có thể hao mòn sau nhiều năm và cần thay thế.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Rối loạn cương dương (ED)

Khó đạt hoặc duy trì sự cương đủ cứng để quan hệ.

Bộ phận giả dương vật (IPP)

Thiết bị cấy ghép tạo ra sự cương khi bạn muốn.

Ống trụ

Hai phần đặt trong dương vật, bơm đầy dịch để làm cứng.

Bơm

Phần trong bìu để bóp bơm căng và nhấn để xả.

Bình chứa

Túi chứa dịch đặt ở bụng dưới.

Kích hoạt

Lần khám sau mổ ~4–6 tuần, lần đầu tiên sử dụng thiết bị và được hướng dẫn cách vận hành.

Tập luyện (Cycling)

Bơm căng và xả hàng ngày sau khi lành — giúp thiết bị hoạt động tốt và duy trì chiều dài.

Gây mê toàn thân

Thuốc giúp bạn ngủ và không đau trong suốt ca phẫu thuật.

CÓ ĐAU KHÔNG? Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống, nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ. Sau đó, hãy chờ đợi đau nhức, sưng và bầm tím ở dương vật và bìu trong vài tuần — băng nâng bìu, chườm đá và thuốc giảm đau sẽ giúp ích. Ca mổ kéo khoảng một tiếng, và nhiều bệnh nhân về nhà trong ngày. Không sử dụng thiết bị cho đến khi bác sĩ phẫu thuật kích hoạt nó.

Cách chuẩn bị (Trước khi phẫu thuật)

- Thực hiện dưới **gây mê toàn thân hoặc gây tê tùy sống** — tuân theo mọi hướng dẫn phẫu thuật (nhịn ăn, và thuốc nào cần ngừng, kể cả thuốc làm loãng máu).
- Phòng ngừa nhiễm trùng là điều cốt yếu:** mọi nhiễm trùng (kể cả nhiễm trùng đường tiết niệu) phải được điều trị trước, và bạn sẽ tắm bằng xà phòng kháng khuẩn và được dùng kháng sinh.
- Không hút thuốc hoặc dùng thuốc lá điện tử**, và nếu bạn có **bệnh tiểu đường**, đội ngũ chăm sóc sẽ muốn đường huyết được kiểm soát tốt — cả hai điều này giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Hãy báo cho nhóm chăm sóc trước nếu bạn:

- Có **bệnh tiểu đường**, hoặc khó sử dụng tay (vì bạn tự vận hành bơm)
- Đã từng phẫu thuật vùng chậu hoặc dương vật, xạ trị, hoặc có bộ phận giả trước đây

Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê hoặc tê từ thắt lưng trở xuống, và được dùng kháng sinh.
- 2 Qua một vết rạch nhỏ (gần bìu hoặc bụng dưới), bác sĩ phẫu thuật đặt **ống trụ** vào dương vật, **bơm** vào bìu, và **bình chứa** vào bụng dưới — tất cả đều dưới da.
- 3 Thiết bị được kiểm tra, sau đó để xả hơi để lạnh. Có thể đặt ống thông ngắn hạn.

Sau khi phẫu thuật

- Chờ đợi **sưng và bầm tím** ở dương vật và bìu trong 1–2 tuần. Mang băng nâng bìu, chườm đá, uống thuốc giảm đau, và giữ vết mổ sạch và khô.
- Không sử dụng thiết bị hoặc quan hệ tình dục cho đến khi bác sĩ cho phép** — thường khoảng **4–6 tuần**. Tại lần khám kích hoạt đó, thiết bị được bơm lần đầu và bạn được hướng dẫn cách vận hành bơm (xả là kỹ năng cần luyện tập nhiều nhất).
- Sau đó, **bơm căng và xả hàng ngày ("cycling")** trong những tháng đầu — giúp thiết bị hoạt động trơn tru và duy trì chiều dài.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc hoặc đến cơ sở y tế nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc đỏ, đau, sưng, hoặc chảy dịch ngày càng tăng tại vết mổ
- Không thể đi tiểu
- Đau dữ dội hoặc ngày càng nặng hơn, hoặc dương vật có màu xanh sẫm hoặc tối

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. IPP là thiết bị ẩn dùng cho ED không đáp ứng các phương pháp khác — bóp bơm trong bìu để cương, nhấn van xả để trở lại mềm.
2. Đây là **lựa chọn lâu dài** (sự cương tự nhiên và thuốc/tiêm sẽ không còn hiệu quả sau đó), nhưng nó **không ảnh hưởng đến việc tiểu tiện, cảm giác, cực khoái, hoặc xuất tinh**.
3. Phòng ngừa nhiễm trùng là quan trọng nhất — điều trị mọi nhiễm trùng trước, không hút thuốc, dùng xà phòng kháng khuẩn và kháng sinh. Không dùng thiết bị cho đến khi được kích hoạt (~4–6 tuần), sau đó tập luyện hàng ngày.